
German Medical Interview Prep Guide



50+ Mock Questions
& Model Answers

German Medical Interview Prep Guide

A focused digital course for doctors preparing for German medical interviews, Fachsprachprüfung-style oral stations, and early clinical communication in Germany.

Scope note: This guide is for language and interview preparation. It uses conservative, general medical content and avoids unstable treatment protocols. Local exam formats vary by Ärztekammer and Bundesland.

Table of Contents

1. Common interview questions with German model answers and English translations
2. Clinical scenario questions - Fachsprachprüfung style
3. General medical knowledge questions in German
4. Pronunciation guide for 100 key medical German terms
5. Five full mock interview scripts
6. Study checklist

How to use this guide

- Read every German answer aloud and then summarize it without looking.
- For every clinical scenario, practise three layers: patient-friendly explanation, doctor-to-doctor summary, and documentation language.
- Record yourself once daily for 5-10 minutes and compare your grammar, word order, and pronunciation against the model phrases.
- Use the mock interviews as scripts first, then repeat them freely with different diagnoses and patient details.

Section 1 - 10 Common Interview Questions with Model Answers

Format: each item includes a German answer suitable for interview practice and a precise English translation. Adjust personal details honestly during the real interview.

1. Stellen Sie sich bitte kurz vor.

Modellantwort Deutsch: Guten Tag. Mein Name ist Dr. Hassan. Ich habe Humanmedizin studiert und mein klinisches Praktikum in verschiedenen Fachbereichen absolviert. Besonders interessiert mich die Orthopädie und Unfallchirurgie, weil ich die Verbindung aus klinischer Untersuchung, Bildgebung, manuellen Fähigkeiten und langfristiger Patientenbetreuung sehr spannend finde. Ich möchte meine medizinischen Kenntnisse vertiefen, strukturiert arbeiten und mich in einem deutschen Team zuverlässig integrieren.

English translation: Good day. My name is Dr. Hassan. I studied medicine and completed clinical internship training in different departments. I am particularly interested in orthopedics and trauma surgery because I find the combination of clinical examination, imaging, manual skills, and long-term patient care very compelling. I want to deepen my medical knowledge, work in a structured way, and integrate reliably into a German team.

2. Warum möchten Sie in Deutschland als Arzt arbeiten?

Modellantwort Deutsch: Deutschland bietet eine sehr strukturierte Weiterbildung, klare klinische Standards und eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Für mich ist es wichtig, in einem System zu arbeiten, in dem Qualität, Dokumentation, Patientensicherheit und kontinuierliche Fortbildung eine große Rolle spielen. Ich bin bereit, die Sprache weiter zu verbessern und Verantwortung schrittweise zu übernehmen.

English translation: Germany offers very structured residency training, clear clinical standards, and close cooperation between professional groups. For me it is important to work in a system where quality, documentation, patient safety, and continuous education play a major role. I am ready to keep improving my language skills and to take responsibility step by step.

3. Warum haben Sie sich für die Orthopädie und Unfallchirurgie entschieden?

Modellantwort Deutsch: Ich interessiere mich für Orthopädie und Unfallchirurgie, weil dieses Fach sehr praktisch, anatomisch und problemorientiert ist. Man sieht häufig einen direkten Zusammenhang zwischen Untersuchung, Diagnose, Therapie und funktionellem Ergebnis. Außerdem gefällt mir, dass man akute Verletzungen behandelt, aber auch chronische Beschwerden begleitet und Patienten dabei hilft, Mobilität und Lebensqualität zurückzugewinnen.

English translation: I am interested in orthopedics and trauma surgery because the specialty is very practical, anatomical, and problem-oriented. One often sees a direct connection between examination, diagnosis, therapy, and functional outcome. I also like that it treats acute injuries but also follows chronic complaints and helps patients regain mobility and quality of life.

4. Wie gehen Sie mit Stress oder hoher Arbeitsbelastung um?

Modellantwort Deutsch: Bei hoher Arbeitsbelastung versuche ich zuerst, Prioritäten zu setzen: Was ist akut, was ist potenziell gefährlich, und was kann geplant erledigt werden? Ich kommuniziere frühzeitig mit dem Team, dokumentiere wichtige Entscheidungen und bitte um Unterstützung, wenn eine Situation meine Erfahrung übersteigt. Für mich sind ruhige Kommunikation und strukturierte Übergaben entscheidend.

English translation: Under a high workload, I first try to prioritize: what is acute, what is potentially dangerous, and what can be done in a planned manner? I communicate early with the team, document important decisions, and ask for support when a situation exceeds my experience. Calm communication and structured handovers are essential to me.

5. Wie würden Sie mit einem Fehler umgehen?

Modellantwort Deutsch: Wenn mir ein Fehler auffällt, würde ich ihn nicht verheimlichen. Ich würde zuerst die Patientensicherheit sichern, dann sofort einen zuständigen Oberarzt oder eine zuständige Oberärztin informieren, den Fehler transparent dokumentieren und gemeinsam besprechen, welche Maßnahmen notwendig sind. Danach würde ich analysieren, wie der Fehler entstanden ist, damit sich die Situation nicht wiederholt.

English translation: If I notice an error, I would not hide it. I would first ensure patient safety, then immediately inform the responsible senior physician, document the error transparently, and discuss together what measures are necessary. After that I would analyze how the error occurred so that the situation is not repeated.

6. Wie kommunizieren Sie mit schwierigen Patienten?

Modellantwort Deutsch: Ich versuche zunächst, ruhig zu bleiben und die Perspektive des Patienten zu verstehen. Viele schwierige Situationen entstehen durch Angst, Schmerzen, Unsicherheit oder Wartezeiten. Ich höre aktiv zu, fasse das Problem zusammen und erkläre die nächsten Schritte in einfacher Sprache. Wenn die Situation eskaliert, hole ich Unterstützung und achte auf Sicherheit für Patient, Personal und andere Patienten.

English translation: I first try to remain calm and understand the patient's perspective. Many difficult situations arise from fear, pain, uncertainty, or waiting times. I listen actively, summarize the problem, and explain the next steps in simple language. If the situation escalates, I get support and pay attention to safety for the patient, staff, and other patients.

7. Was bedeutet Teamarbeit für Sie?

Modellantwort Deutsch: Teamarbeit bedeutet für mich, Informationen klar weiterzugeben, Aufgaben zuverlässig zu übernehmen und die Kompetenz anderer Berufsgruppen zu respektieren. Gute Patientenversorgung entsteht nur, wenn Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapie, Radiologie, Labor und Verwaltung gut zusammenarbeiten. Ich halte kurze, präzise Kommunikation und eine respektvolle Haltung für besonders wichtig.

English translation: Teamwork means giving information clearly, taking over tasks reliably, and respecting the competence of other professional groups. Good patient care only develops when physicians, nurses, physiotherapy, radiology, laboratory, and administration work well together. I consider short, precise communication and a respectful attitude particularly important.

8. Wie schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein?

Modellantwort Deutsch: Meine Deutschkenntnisse entwickeln sich kontinuierlich. Ich kann medizinische Inhalte strukturiert erklären und bin daran gewöhnt, gezielt medizinische Fachbegriffe zu lernen. Gleichzeitig weiß ich, dass Umgangssprache, Dialekte und schnelle Klinikkommunikation anspruchsvoll sein können. Deshalb übe ich täglich Anamnese, Patientenvorstellung, Dokumentation und Aussprache.

English translation: My German skills are developing continuously. I can explain medical content in a structured way and I am used to learning medical terminology systematically. At the same time, I know that colloquial language, dialects, and fast clinical communication can be demanding. Therefore, I practise history taking, case presentation, documentation, and pronunciation daily.

9. Was erwarten Sie von Ihrer Weiterbildung?

Modellantwort Deutsch: Ich erwarte eine strukturierte Weiterbildung mit zunehmender Verantwortung, regelmäßiger Rückmeldung und klaren Lernzielen. Besonders wichtig sind mir saubere klinische Untersuchung, korrekte Indikationsstellung, sichere Dokumentation und das Lernen im OP sowie in der Notaufnahme. Ich möchte fachlich zuverlässig werden und langfristig ein wertvolles Mitglied des Teams sein.

English translation: I expect structured residency training with increasing responsibility, regular feedback, and clear learning goals. Clean clinical examination, correct indication setting, safe documentation, and learning in the operating room and emergency department are especially important to me. I want to become professionally reliable and, in the long term, a valuable team member.

10. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Modellantwort Deutsch: In fünf Jahren möchte ich ein sicherer, gut integrierter Assistenzarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie sein, mit soliden praktischen Fähigkeiten, guter Kommunikation und einem klaren Weiterbildungspfad. Ich möchte selbstständig arbeiten können, aber auch wissen, wann ich Unterstützung brauche. Mein Ziel ist es, fachlich stark und menschlich verlässlich zu sein.

English translation: In five years I would like to be a confident, well-integrated resident in orthopedics and trauma surgery, with solid practical skills, good communication, and a clear training pathway. I want to be able to work independently but also know when I need support. My goal is to be strong professionally and reliable as a person.

Section 2 - 20 Clinical Scenario Questions - FSP Style

Use these scenarios to practise an Anamnesegespräch, a patient-friendly explanation, and an Arzt-Arzt-Gespräch. The prompts are intentionally exam-style and should be answered aloud.

1. Akuter Thoraxschmerz

Ein 58-jähriger Patient kommt mit retrosternalem Druckgefühl, Übelkeit und Kaltschweißigkeit. Welche Fragen stellen Sie, welche Differenzialdiagnosen nennen Sie, und wie erklären Sie dem Patienten die nächsten Schritte?

Wichtige Fragen: Schmerzbeginn, Charakter, Ausstrahlung, Belastungsabhängigkeit, Dyspnoe, Übelkeit, Synkope, Risikofaktoren, Medikamente und Allergien.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Akutes Koronarsyndrom, Lungenembolie, Aortensyndrom, Pneumothorax, Reflux, muskuloskelettale Schmerzen.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir müssen rasch Herz und Lunge überprüfen. Dazu gehören EKG, Blutwerte, Überwachung und weitere Bildgebung je nach Befund.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

2. Dyspnoe und Beinödem

Eine 72-jährige Patientin berichtet über zunehmende Luftnot und geschwollene Beine. Strukturieren Sie Anamnese, klinische Untersuchung und Verdachtsdiagnosen.

Wichtige Fragen: Beginn, Belastbarkeit, Orthopnoe, Husten, Fieber, Thoraxschmerz, Gewichtszunahme, Beinödeme, Vorerkrankungen und Diuretika.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Herzinsuffizienz, Pneumonie, COPD-Exazerbation, Lungenembolie, Anämie, Niereninsuffizienz.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir kontrollieren Sauerstoff, Herz, Lunge und Blutwerte, damit wir die Ursache der Luftnot sicher eingrenzen können.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

3. Oberbauchschmerz

Ein 45-jähriger Patient hat rechtsseitige Oberbauchschmerzen nach fettreichem Essen. Fragen Sie nach Begleitsymptomen und erklären Sie mögliche Diagnostik.

Wichtige Fragen: Lokalisation, Kolikcharakter, Zusammenhang mit Essen, Fieber, Ikterus, Erbrechen, Stuhl- und Urinfarbe, Alkohol, Medikamente.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Gallensteine, Cholezystitis, Pankreatitis, Ulkus, Hepatitis, kardiale Ursache.

Patientenfreundliche Erklärung: Ein Ultraschall und Blutwerte helfen uns, Gallenblase, Leber und Bauchspeicheldrüse zu beurteilen.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

4. Akuter Kopfschmerz

Eine 34-jährige Patientin beschreibt den stärksten Kopfschmerz ihres Lebens. Welche Warnzeichen müssen Sie abfragen und wie handeln Sie?

Wichtige Fragen: Maximale Schmerzstärke, plötzlicher Beginn, Nackensteifigkeit, Fieber, neurologische Ausfälle, Sehstörung, Trauma, Antikoagulation.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Subarachnoidalblutung, Meningitis, Migräne, Sinusvenenthrombose, hypertensive Krise.

Patientenfreundliche Erklärung: Bei einem plötzlich sehr starken Kopfschmerz müssen wir gefährliche Ursachen sofort ausschließen.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

5. Schwindel

Ein älterer Patient berichtet über neu aufgetretenen Drehschwindel und Gangunsicherheit. Wie unterscheiden Sie peripheren von zentralem Schwindel sprachlich und klinisch?

Wichtige Fragen: Dreh- oder Schwankschwindel, Dauer, Lagerungsabhängigkeit, Hörminderung, Tinnitus, Doppelbilder, Dysarthrie, Ataxie.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkrahen: Benigner Lagerungsschwindel, Vestibularisneuritis, Schlaganfall, Hypotonie, Rhythmusstörung, Medikamentennebenwirkung.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir prüfen Gleichgewicht, Augenbewegungen, Kreislauf und neurologische Zeichen, weil nicht jeder Schwindel harmlos ist.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

6. Fieber und Husten

Eine 67-jährige Patientin hat Fieber, produktiven Husten und reduzierte Belastbarkeit. Führen Sie eine fokussierte Anamnese und nennen Sie Untersuchungen.

Wichtige Fragen: Dauer, Auswurf, Atemnot, Thoraxschmerz, Reise, Kontaktpersonen, Impfstatus, Vorerkrankungen, Rauchen.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkrahen: Pneumonie, Bronchitis, Influenza/COVID-ähnlicher Infekt, COPD-Exazerbation, Herzinsuffizienz.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir hören die Lunge ab, messen Sauerstoff und prüfen Blutwerte; eventuell brauchen wir ein Röntgenbild.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

7. Abdominelle Schmerzen bei Kind

Die Mutter eines 9-jährigen Kindes berichtet über Bauchschmerzen, Erbrechen und Fieber. Welche Fragen sind wichtig, und wann ist eine chirurgische Abklärung nötig?

Wichtige Fragen: Schmerzort, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Stuhlgang, Wasserlassen, Appetit, Hoden-/Leistenschmerz bei Jungen.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkrahen: Appendizitis, Gastroenteritis, Harnwegsinfekt, Invagination, Obstipation, Hodentorsion je nach Befund.

Patientenfreundliche Erklärung: Bei Kindern beobachten wir Verlauf und Allgemeinzustand besonders genau und holen früh chirurgische Hilfe bei Warnzeichen.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

8. Akuter Rückenschmerz

Ein 50-jähriger Patient hat lumbale Schmerzen nach Heben. Welche Red Flags fragen Sie ab, und wie erklären Sie konservative Maßnahmen?

Wichtige Fragen: Trauma, Fieber, Tumoranamnese, Gewichtsverlust, Blasen-/Mastdarmstörung, Sattelanästhesie, Lähmung, Steroide.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkrahen: Unspezifischer Rückenschmerz, Bandscheibenvorfall, Fraktur, Infektion, Tumor, Cauda-equina-Syndrom.

Patientenfreundliche Erklärung: Wenn keine Warnzeichen bestehen, behandeln wir meist konservativ; bei Warnzeichen braucht es sofortige Abklärung.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

9. Sturz auf die Hand

Eine Patientin ist auf die ausgestreckte Hand gefallen. Erklären Sie Anamnese, Inspektion, Durchblutung-Motorik-Sensibilität und Röntgenindikation.

Wichtige Fragen: Sturzmechanismus, Schmerzort, Schwellung, Fehlstellung, offene Wunde, Taubheit, Bewegung der Finger, dominante Hand.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkrahen: Distale Radiusfraktur, Skaphoidfraktur, Luxation, Bandverletzung, Prellung.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir prüfen Durchblutung, Bewegung und Gefühl und machen ein Röntgenbild, um einen Bruch auszuschließen.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

10. Knieverletzung beim Sport

Ein 22-jähriger Patient berichtet über Verdrehtrauma, Knacken und Schwellung. Welche Strukturen kommen infrage, und welche klinischen Tests würden Sie nennen?

Wichtige Fragen: Verdrehtrauma, Knacken, sofortige Schwellung, Blockade, Instabilität, Belastbarkeit, frühere Verletzungen.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Kreuzbandruptur, Meniskusläsion, Seitenbandverletzung, Patellaluxation, Fraktur.

Patientenfreundliche Erklärung: Schwellung und Instabilität zeigen uns, ob Bänder oder Meniskus betroffen sein könnten; Bildgebung folgt nach Befund.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

11. Hüftschmerz nach Sturz

Eine 80-jährige Patientin kann nach einem Sturz nicht mehr auftreten. Wie kommunizieren Sie Verdacht, Immobilisation, Bildgebung und Schmerztherapie?

Wichtige Fragen: Sturzhergang, Gehfähigkeit, Beinverkürzung/Außenrotation, Antikoagulation, Vorerkrankungen, Osteoporoserisiko.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Schenkelhalsfraktur, pertrochantäre Fraktur, Beckenfraktur, Prellung.

Patientenfreundliche Erklärung: Bis zum Ausschluss eines Bruchs sollte das Bein nicht belastet werden; wir geben Schmerzmittel und machen Bildgebung.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

12. Hyperglykämie

Ein Patient mit Diabetes berichtet über Durst, häufiges Wasserlassen und Müdigkeit. Welche Werte und Begleitumstände fragen Sie ab?

Wichtige Fragen: Blutzuckerwerte, Durst, Polyurie, Gewichtsverlust, Infektzeichen, Insulin/Medikamente, Erbrechen, Bewusstsein.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Entgleister Diabetes, diabetische Ketoazidose, hyperosmolares Syndrom, Infekttigger.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir kontrollieren Zucker, Flüssigkeitshaushalt, Ketone und Elektrolyte und behandeln die Ursache der Entgleisung.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

13. Synkope

Eine 29-jährige Patientin kollabierte kurz in der U-Bahn. Fragen Sie Ereignisablauf, Prodromi, Medikamente und Risikofaktoren ab.

Wichtige Fragen: Ablauf, Prodromi, Lage, Belastung, Dauer, Zungenbiss, Einnässen, Herzkrankheit, Medikamente, Familienanamnese.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Vasovagale Synkope, orthostatische Hypotonie, Rhythmusstörung, Krampfanfall, Lungenembolie.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir suchen nach harmlosen und gefährlichen Ursachen; wichtig sind EKG, Kreislaufwerte und der genaue Ablauf.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

14. Neurologisches Defizit

Ein Patient zeigt plötzlich Sprachstörung und Armparese. Wie erklären Sie die Dringlichkeit, ohne Panik zu erzeugen?

Wichtige Fragen: Last seen well, Sprachstörung, Paresen, Sensibilität, Gesichtsfeld, Kopfschmerz, Antikoagulation, Blutzucker.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Ischämischer Schlaganfall, intrazerebrale Blutung, Hypoglykämie, Migräne mit Aura, Krampfanfall mit Todd-Parese.

Patientenfreundliche Erklärung: Bei Schlaganfallverdacht zählt jede Minute; wir handeln schnell und erklären jeden Schritt kurz und ruhig.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

15. Blut im Stuhl

Ein 60-jähriger Patient berichtet über Hämatochezie. Welche Anamnese, Risiken und Untersuchungen sind relevant?

Wichtige Fragen: Farbe, Menge, Schmerzen, Stuhlveränderung, Gewichtsverlust, Medikamente, Antikoagulation, Familienanamnese.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Hämorrhoiden, Divertikelblutung, Kolitis, Polyp/Tumor, obere GI-Blutung bei Meläna.

Patientenfreundliche Erklärung: Wir klären, wie stark die Blutung ist, ob Kreislaufgefahr besteht und welche Diagnostik nötig ist.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

16. Dysurie

Eine junge Frau hat Brennen beim Wasserlassen und häufigen Harndrang. Fragen Sie nach Warnzeichen und erklären Sie Urinuntersuchung.

Wichtige Fragen: Brennen, Pollakisurie, Fieber, Flankenschmerz, Schwangerschaft, Ausfluss, frühere Infekte, Antibiotikaallergie.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Unkomplizierter Harnwegsinfekt, Pyelonephritis, Urethritis, Vaginitis, Steinleiden.

Patientenfreundliche Erklärung: Eine Urinuntersuchung zeigt Hinweise auf Entzündung; Fieber oder Flankenschmerz ändern die Dringlichkeit.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

17. Allergische Reaktion

Ein Patient entwickelt nach Antibiotika Juckreiz, Quaddeln und Atemnot. Welche Sofortmaßnahmen und Dokumentationspunkte sind wichtig?

Wichtige Fragen: Auslöser, Zeitpunkt, Hautreaktion, Atemnot, Schwellung, Kreislauf, frühere Reaktionen, Medikamente.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Urtikaria, Anaphylaxie, Arzneimittellexanthem, Asthmaattacke, Angioödem.

Patientenfreundliche Erklärung: Atemnot oder Kreislaufprobleme sind Warnzeichen; wir behandeln sofort und dokumentieren den Auslöser genau.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

18. Präoperative Aufklärung

Ein Patient soll operiert werden und fragt nach Risiken. Formulieren Sie eine verständliche Erklärung zu Nutzen, Alternativen und typischen Risiken.

Wichtige Fragen: Indikation, Beschwerden, Erwartung, Vorerkrankungen, Medikamente, Blutverdünner, Allergien, frühere Narkoseprobleme.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Nutzen-Risiko-Abwägung, konservative Alternative, Narkoserisiko, Blutung, Infektion, Thrombose, organspezifische Risiken.

Patientenfreundliche Erklärung: Sie sollen verstehen, warum wir den Eingriff empfehlen, welche Alternativen es gibt und welche Risiken realistisch sind.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

19. Entlassungsgespräch

Eine Patientin wird nach Pneumonie entlassen. Erklären Sie Medikamente, Warnzeichen, Kontrolle und Schonung.

Wichtige Fragen: Aktuelle Beschwerden, Belastbarkeit, Medikamente, Nebenwirkungen, häusliche Versorgung, Kontrolle, Warnzeichen.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraumen: Rezidiv/Komplikation, Nebenwirkung, unzureichende häusliche Versorgung, erneute Verschlechterung.

Patientenfreundliche Erklärung: Sie bekommen klare Hinweise, wann Sie wiederkommen müssen und wie Sie Medikamente und Kontrolle organisieren.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

20. Übergabe an Kollegin

Stellen Sie einen aufgenommenen Patienten strukturiert im SBAR-Stil vor: Situation, Background, Assessment, Recommendation.

Wichtige Fragen: Aufnahmegrund, relevante Vorgeschichte, aktuelle Befunde, Diagnostik, Therapie, offene Aufgaben, Eskalationskriterien.

Wichtige Differenzialdiagnosen / Denkraum: SBAR: Situation, Background, Assessment, Recommendation.

Patientenfreundliche Erklärung: Die Übergabe muss kurz, vollständig und priorisiert sein, damit keine sicherheitsrelevante Information verloren geht.

Antwortstruktur: 1) Leitsymptom und Zeitverlauf klären. 2) Relevante Begleitbeschwerden und Risikofaktoren abfragen. 3) Vorbefunde, Medikamente und Allergien erfassen. 4) Befund- und Diagnostikplan nennen. 5) Patientengerecht erklären, was als Nächstes passiert.

Section 3 - 20 General Medical Knowledge Questions in German

These questions train concise German explanations. The answers are intentionally short and safe for oral examination practice.

1. Was ist der Unterschied zwischen Symptom und Befund?

Antwort: Ein Symptom ist eine subjektive Beschwerde des Patienten, zum Beispiel Schmerz. Ein Befund ist eine objektiv erhobene Beobachtung oder Messung, zum Beispiel Fieber, Rötung oder ein Laborwert.

2. Was bedeutet Differenzialdiagnose?

Antwort: Eine Differenzialdiagnose ist eine mögliche alternative Erklärung für Beschwerden oder Befunde. Man prüft sie systematisch, bis die wahrscheinlichste Diagnose bestätigt oder ausgeschlossen ist.

3. Welche Vitalparameter erheben Sie initial?

Antwort: Bewusstsein, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, Puls, Blutdruck, Temperatur und Schmerzstärke. Je nach Situation zusätzlich Blutzucker und EKG.

4. Was bedeutet Anamnese?

Antwort: Anamnese bedeutet die strukturierte Erhebung der Krankengeschichte durch Fragen zu aktuellen Beschwerden, Vorerkrankungen, Medikamenten, Allergien, Familienanamnese, Sozialanamnese und Risikofaktoren.

5. Was ist eine Allergieanamnese?

Antwort: Dabei fragt man nach bekannten Allergien, auslösendem Stoff, Reaktion, Schweregrad, Zeitpunkt und bisheriger Behandlung. Besonders wichtig sind Medikamentenallergien.

6. Was ist eine Kontraindikation?

Antwort: Eine Kontraindikation ist ein Umstand, bei dem eine Untersuchung oder Behandlung nicht oder nur mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden sollte, weil der Schaden den Nutzen überwiegen kann.

7. Was bedeutet Indikation?

Antwort: Indikation bedeutet der medizinisch begründete Anlass für eine diagnostische oder therapeutische Maßnahme.

8. Was ist der Unterschied zwischen akut und chronisch?

Antwort: Akut bedeutet plötzlich oder kurzfristig auftretend. Chronisch bedeutet länger bestehend oder wiederkehrend, meist über einen längeren Zeitraum.

9. Welche Bestandteile hat eine körperliche Untersuchung?

Antwort: Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation. Je nach Fachgebiet kommen Funktionsprüfung, neurologischer Status oder spezielle Tests hinzu.

10. Was ist ein EKG?

Antwort: Ein Elektrokardiogramm zeichnet die elektrische Aktivität des Herzens auf und hilft bei der Beurteilung von Rhythmusstörungen, Ischämiezeichen und Leitungsstörungen.

11. Was bedeutet Sepsis?

Antwort: Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion infolge einer fehlregulierten Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Sie ist ein medizinischer Notfall.

12. Was ist eine Embolie?

Antwort: Eine Embolie ist der Verschluss eines Gefäßes durch verschlepptes Material, häufig ein Blutgerinnsel. Eine Lungenembolie betrifft Gefäße der Lunge.

13. Was bedeutet Fraktur?

Antwort: Eine Fraktur ist ein Knochenbruch. Wichtig sind Lokalisation, Dislokation, offene oder geschlossene Verletzung, Weichteilschaden und Durchblutung-Motorik-Sensibilität.

14. Was ist Osteoporose?

Antwort: Osteoporose ist eine Erkrankung mit verminderter Knochenmasse und erhöhter Frakturgefahr, besonders bei älteren Menschen und nach Bagateltrauma.

15. Was ist eine Thrombose?

Antwort: Eine Thrombose ist die Bildung eines Blutgerinnsels in einem Gefäß. Klinisch relevant ist besonders die tiefe Beinvenenthrombose wegen des Risikos einer Lungenembolie.

16. Was ist eine Pneumonie?

Antwort: Eine Pneumonie ist eine Entzündung des Lungengewebes, häufig infektiös. Typische Zeichen können Fieber, Husten, Auswurf, Dyspnoe und abgeschwächtes Allgemeinbefinden sein.

17. Was ist Hypertonie?

Antwort: Hypertonie bedeutet dauerhaft erhöhter Blutdruck. Sie ist ein wichtiger Risikofaktor für Schlaganfall, Herzinfarkt, Nieren- und Gefäßschäden.

18. Was ist Diabetes mellitus?

Antwort: Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung mit chronisch erhöhtem Blutzucker durch gestörte Insulinwirkung, Insulinsekretion oder beides.

19. Was bedeutet Aufklärung?

Antwort: Aufklärung ist das verständliche Informieren des Patienten über Diagnose, Maßnahme, Nutzen, Risiken, Alternativen und Folgen der Nichtbehandlung, damit eine informierte Einwilligung möglich ist.

20. Was ist eine Epikrise?

Antwort: Eine Epikrise ist die zusammenfassende medizinische Beurteilung eines Krankheitsverlaufs, meist am Ende eines Arztbriefs.

Section 4 - Pronunciation Guide for 100 Key Medical German Terms

The pronunciation column uses a simple English-friendly approximation, not formal IPA. In German, stress usually falls on the first syllable of native words, but many medical loanwords differ. Practise slowly, with clear vowels and final consonants.

Term	Pronunciation	Meaning
Anamnese	ah-nam-NAY-zuh	history taking
Untersuchung	OON-ter-zoo-khoong	examination
Beschwerde	buh-SHVAIR-duh	complaint
Schmerzen	SHMAIR-tsen	pain
Übelkeit	OO-bel-kite	nausea
Erbrechen	air-BRE-khen	vomiting
Schwindel	SHVIN-del	dizziness
Atemnot	AH-tem-noht	shortness of breath
Husten	HOO-sten	cough
Auswurf	OWS-voorf	sputum
Fieber	FEE-ber	fever
Schüttelfrost	SHUE-tel-froht	chills
Bewusstsein	buh-VOOSST-zine	consciousness
Blutdruck	BLOOT-drook	blood pressure
Puls	pools	pulse
Sauerstoffsättigung	ZOW-er-shtoff-ZET-ti-goong	oxygen saturation
Blutzucker	BLOOT-tsook-er	blood glucose
Herzfrequenz	HAIRTS-freh-kvents	heart rate
Atemfrequenz	AH-tem-freh-kvents	respiratory rate
Temperatur	tem-peh-rah-TOOR	temperature
Diagnose	dee-ag-NOH-zuh	diagnosis
Verdachtsdiagnose	fair-DAKHTS-dee-ag-noh-zuh	suspected diagnosis
Differenzialdiagnose	dif-feh-ren-tsee-AHL-dee-ag-noh-zuh	differential diagnosis
Behandlung	buh-HAND-loong	treatment
Therapie	teh-rah-PEE	therapy

Term	Pronunciation	Meaning
Medikament	meh-dee-kah-MENT	medication
Nebenwirkung	NAY-ben-vir-koong	side effect
Allergie	ah-lair-GEE	allergy
Unverträglichkeit	OON-fair-trehg-likh-kite	intolerance
Einwilligung	INE-vil-li-goong	consent
Aufklärung	OWF-klair-oong	informed explanation
Risiko	REE-zee-ko	risk
Komplikation	kom-plee-kah-TSYOHN	complication
Notfall	NOHT-fal	emergency
Rettungsdienst	RET-toongs-deenst	emergency service
Krankenhaus	KRANK-en-house	hospital
Notaufnahme	NOHT-owf-nah-muh	emergency department
Station	shtah-TSYOHN	ward
Entlassung	ent-LAHS-soong	discharge
Überweisung	OO-ber-vy-zoong	referral

Term	Pronunciation	Meaning
Arztbrief	ARTST-breef	medical letter
Befund	buh-FOONT	finding/report
Laborwert	lah-BOR-vairt	lab value
Röntgen	ROENT-gen	X-ray
Computertomographie	kom-PYOO-ter-toh-moh-grah-FEE	CT scan
Magnetresonanztomographie	mag-NAYT-reh-zoh-nants-toh-moh-grah-FEE	MRI
Ultraschall	OOL-trah-shal	ultrasound
Endoskopie	en-doh-sko-PEE	endoscopy
Biopsie	bee-op-SEE	biopsy
Abstrich	AHP-shtrikh	swab

Term	Pronunciation	Meaning
Infektion	in-fek-TSYOHN	infection
Entzündung	ent-TSUEN-doong	inflammation
Sepsis	ZEP-sis	sepsis
Pneumonie	pnoi-moh-NEE	pneumonia
Bronchitis	bron-KHEE-tis	bronchitis
Asthma	AS-ma	asthma
COPD	tseh-oh-peh-DEH	COPD
Lungenembolie	LOONG-en-em-boh-LEE	pulmonary embolism
Thrombose	trom-BOH-zuh	thrombosis
Herzinfarkt	HAIRTS-in-farkt	myocardial infarction
Herzinsuffizienz	HAIRTS-in-zoo-fee-TSEE-ents	heart failure
Schlaganfall	SHLAHG-an-fal	stroke
Krampfanfall	KRAMPF-an-fal	seizure
Migräne	mee-GRAY-nuh	migraine
Diabetes	dee-ah-BAY-tes	diabetes
Hypertonie	hue-per-toh-NEE	hypertension
Hypotonie	hue-poh-toh-NEE	hypotension
Niereninsuffizienz	NEE-ren-in-zoo-fee-TSEE-ents	renal insufficiency
Leberzirrhose	LAY-ber-tsee-ROH-zuh	liver cirrhosis
Anämie	ah-nay-MEE	anemia
Fraktur	frak-TOOR	fracture
Luxation	look-sah-TSYOHN	dislocation
Prellung	PREL-loong	contusion
Verstauchung	fair-SHTOW-khoong	sprain
Bänderriss	BEN-der-riss	ligament tear

Term	Pronunciation	Meaning
Meniskus	meh-NIS-koos	meniscus
Kreuzband	KROITS-bant	cruciate ligament
Osteoporose	os-teh-oh-poh-ROH-zuh	osteoporosis
Wirbelsäule	VEER-bel-zoi-luh	spine
Gelenk	guh-LENK	joint
Muskulatur	moos-koo-lah-TOOR	musculature
Sehne	ZAY-nuh	tendon
Nerv	nairf	nerve
Gefäß	guh-FESS	vessel
Durchblutung	DOORKH-bloo-toong	perfusion
Motorik	moh-TOH-rik	motor function

Term	Pronunciation	Meaning
Sensibilität	zen-zee-bee-lee-TET	sensation
Reflex	reh-FLEKS	reflex
Schwellung	SHVEL-loong	swelling
Rötung	ROE-toong	redness
Wunde	VOON-duh	wound
Naht	naht	suture
Verband	fair-BANT	dressing
Operation	oh-peh-rah-TSYOHN	operation
Narkose	nar-KOH-zuh	anesthesia
Blutung	BLOO-toong	bleeding
Gerinnung	guh-RIN-noong	coagulation
Antibiotikum	an-tee-bee-OH-tee-koom	antibiotic
Schmerzmittel	SHMAIRTS-mit-tel	painkiller
Physiotherapie	fue-zee-oh-teh-rah-PEE	physiotherapy

Section 5 - Five Full Mock Interview Scripts

Each script follows a practical pattern: greeting, focused history, patient-friendly explanation, case presentation, and examiner questions.

Mock 1 - Chest Pain / Possible Acute Coronary Syndrome

Rolle	Skript
Arzt	Guten Tag, mein Name ist Dr. Hassan. Ich würde Ihnen gerne einige Fragen stellen. Was führt Sie heute zu uns?
Patient	Ich habe seit ungefähr einer Stunde Druck auf der Brust.
Arzt	Wo genau spüren Sie den Druck? Strahlt er in Arm, Rücken, Hals oder Kiefer aus?
Patient	Er ist hinter dem Brustbein und zieht in den linken Arm.
Arzt	Haben Sie Luftnot, Übelkeit, Schweißausbruch oder Schwindel bemerkt?
Patient	Mir ist übel und ich bin ganz kalt verschwitzt.
Arzt	Das nehmen wir sehr ernst. Wir schreiben sofort ein EKG, kontrollieren Blutdruck, Puls und Sauerstoff und nehmen Blut ab, unter anderem Herzwerte. Bitte bleiben Sie liegen.
Arzt an Prüfer	Der Patient berichtet über akuten retrosternalen Druckschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm, Übelkeit und Kaltschweißigkeit. Differenzialdiagnostisch denke ich zuerst an ein akutes Koronarsyndrom, außerdem an Lungenembolie, Aortensyndrom, Pneumothorax und gastroösophageale Ursachen. Ich würde ein 12-Kanal-EKG, Troponinverlauf, Vitalparameter, Zugang, Monitoring und weitere Diagnostik nach Befund veranlassen.

Mock 2 - Abdominal Pain / Suspected Cholecystitis

Rolle	Skript
Arzt	Seit wann bestehen die Bauchschmerzen und wo sind sie am stärksten?
Patientin	Seit gestern Abend, rechts oben im Bauch.
Arzt	Sind die Schmerzen nach dem Essen stärker geworden? Haben Sie Fieber, Übelkeit, Erbrechen oder Gelbfärbung der Haut bemerkt?
Patientin	Nach dem Essen war es schlimmer. Mir ist übel, Fieber weiß ich nicht.
Arzt	Ich werde den Bauch vorsichtig untersuchen und Blut abnehmen. Außerdem ist ein Ultraschall sinnvoll, um Gallenblase, Gallenwege und Leber zu beurteilen.
Arzt an Prüfer	Bei rechtsseitigen Oberbauchschmerzen nach fettreicher Mahlzeit denke ich an Cholezystolithiasis oder akute Cholezystitis. Wichtig sind Fieber, Ikterus, Entzündungswerte, Cholestaseparameter und Sonographie. Differenzialdiagnosen sind Pankreatitis, Ulkus, Hepatitis, Pneumonie basal und kardiale Ursachen.

Mock 3 - Fall on Outstretched Hand / Distal Radius Fracture

Rolle	Skript
Arzt	Wie ist der Sturz genau passiert? Sind Sie auf die ausgestreckte Hand gefallen?
Patient	Ja, ich bin ausgerutscht und direkt auf die rechte Hand gefallen.
Arzt	Können Sie die Finger bewegen? Haben Sie Taubheitsgefühl oder Kribbeln?
Patient	Die Finger kann ich bewegen, aber das Handgelenk tut stark weh.
Arzt	Ich prüfe jetzt Durchblutung, Motorik und Sensibilität. Danach benötigen wir ein Röntgenbild des Handgelenks in zwei Ebenen.
Arzt an Prüfer	Es besteht der Verdacht auf eine distale Radiusfraktur. Ich untersuche Fehlstellung, Schwellung, offene Verletzung, Druckschmerz und DMS distal. Anschließend Röntgen in zwei Ebenen, Analgesie, Ruhigstellung und je nach Befund Reposition beziehungsweise operative Abklärung.

Mock 4 - Dyspnea / Possible Pneumonia or Heart Failure

Rolle	Skript
Arzt	Seit wann haben Sie Luftnot? Tritt sie in Ruhe oder nur bei Belastung auf?

Rolle	Skript
Patientin	Seit drei Tagen, mittlerweile auch beim Gehen in der Wohnung.
Arzt	Haben Sie Husten, Auswurf, Fieber, Brustschmerzen oder geschwollene Beine?
Patientin	Ich huste gelblichen Auswurf und hatte gestern Fieber.
Arzt	Wir messen Sauerstoff, hören Lunge und Herz ab, nehmen Blut ab und machen wahrscheinlich ein Röntgenbild der Lunge.
Arzt an Prüfer	Die Patientin hat progrediente Dyspnoe mit produktivem Husten und Fieber. Verdacht auf Pneumonie, differenzialdiagnostisch Herzinsuffizienz, Exazerbation einer COPD, Lungenembolie und Anämie. Ich plane Vitalparameter, SpO2, Auskultation, Labor mit Entzündungswerten, Blutgasanalyse je nach Klinik und Röntgen-Thorax.

Mock 5 - Neurological Deficit / Stroke Alarm

Rolle	Skript
Arzt	Seit wann bestehen die Sprachprobleme und die Schwäche im Arm? Wissen Sie die genaue Uhrzeit?
Angehöriger	Es hat vor etwa 40 Minuten angefangen.
Arzt	Nimmt der Patient Blutverdünner? Gab es Sturz, Krampfanfall oder starke Kopfschmerzen?
Angehöriger	Er nimmt Blutdrucktabletten, aber keine Blutverdünner.
Arzt	Das kann ein Schlaganfall sein. Wir müssen sofort handeln, weil die Zeit entscheidend ist. Wir machen eine neurologische Untersuchung, messen Blutzucker und Blutdruck und veranlassen eine dringende Bildgebung des Kopfes.
Arzt an Prüfer	Akut aufgetretene Aphasie und Armparese seit 40 Minuten sprechen für einen Schlaganfall bis zum Beweis des Gegenteils. Ich würde Notfallalgorithmus aktivieren, NIHSS-orientiert untersuchen, Vitalparameter und BZ prüfen, Kontraindikationen erfragen, CT/MRT nach lokalem Standard veranlassen und die Stroke Unit beziehungsweise Neurologie einbeziehen.

Bonus - High-Yield German Medical Interview Phrase Bank

Use these phrases to make answers sound natural, safe, and clinically structured.

Opening and consent

- Darf ich Ihnen zunächst einige Fragen stellen?
- Ich werde Ihnen jeden Schritt erklären, bevor ich Sie untersuche.
- Sind Sie damit einverstanden, dass ich Sie untersuche?
- Wenn Ihnen etwas unangenehm ist, sagen Sie mir bitte sofort Bescheid.
- Ich möchte sicherstellen, dass ich Sie richtig verstanden habe.

Pain history

- Seit wann bestehen die Schmerzen?
- Wo genau tut es weh?
- Wie würden Sie den Schmerz beschreiben: stechend, drückend, brennend oder krampfartig?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Was macht die Schmerzen besser oder schlechter?
- Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10?

Safety and escalation

- Das nehmen wir sehr ernst.
- Ich informiere jetzt die zuständige Oberärztin / den zuständigen Oberarzt.
- Wir überwachen Sie engmaschig.
- Bitte bleiben Sie zunächst nüchtern, bis wir die Ursache geklärt haben.
- Bitte stehen Sie nicht alleine auf; klingeln Sie, wenn Sie Hilfe brauchen.

Explaining tests

- Das EKG zeigt uns die elektrische Aktivität des Herzens.
- Mit der Blutuntersuchung prüfen wir Entzündungswerte, Organwerte und weitere wichtige Parameter.
- Der Ultraschall ist schmerzfrei und hilft uns, innere Organe zu beurteilen.
- Das Röntgenbild hilft uns, einen Knochenbruch auszuschließen oder zu bestätigen.
- Die Computertomographie liefert sehr genaue Schnittbilder und ist bei bestimmten Notfällen wichtig.

Doctor-to-doctor presentation

- Ich stelle Ihnen kurz den Fall vor.
- Es handelt sich um eine/n ...-jährige/n Patientin/Patienten mit ...
- Leitsymptom ist ... seit ...
- An relevanten Vorerkrankungen bestehen ...
- Die aktuelle Medikation umfasst ...
- Klinisch zeigte sich ...
- Differenzialdiagnostisch denke ich an ...
- Als nächstes würde ich ... veranlassen.

Closing

- Haben Sie dazu noch Fragen?
- Ich fasse kurz zusammen, was wir besprochen haben.
- Bitte melden Sie sich sofort, wenn die Beschwerden stärker werden.
- Wir besprechen die Ergebnisse, sobald sie vorliegen.
- Ich kümmere mich jetzt um die nächsten Schritte.

Structured Templates for Fast Oral Practice

1. One-minute patient presentation template

Es handelt sich um eine/n [Alter]-jährige/n Patientin/Patienten, die/der sich wegen [Leitsymptom] seit [Zeitpunkt] vorstellt. Die Beschwerden sind [Charakter], lokalisiert in [Ort], mit/ohne Ausstrahlung nach [Ort]. Begleitsymptome sind [Symptome]. Relevante Vorerkrankungen sind [Vorerkrankungen], die Medikation umfasst [Medikamente], Allergien sind [ja/nein]. Klinisch zeigte sich [Befund]. Differenzialdiagnostisch denke ich an [Diagnosen]. Ich würde [Diagnostik/Therapie] veranlassen.

2. Patient-friendly explanation template

Ihre Beschwerden können verschiedene Ursachen haben. Einige davon sind harmlos, andere müssen wir schnell ausschließen. Deshalb kontrollieren wir jetzt [Untersuchung 1], [Untersuchung 2] und [Untersuchung 3]. Danach besprechen wir die Ergebnisse und entscheiden gemeinsam die nächsten Schritte.

3. Informed consent template

Wir empfehlen diese Maßnahme, weil [Grund]. Der Nutzen ist [Nutzen]. Wie bei jeder medizinischen Maßnahme gibt es Risiken, zum Beispiel [Risiken]. Alternativen wären [Alternativen]. Ohne die Maßnahme kann [Folge] passieren. Haben Sie alles verstanden und haben Sie noch Fragen?

4. Emergency escalation template

Aufgrund Ihrer Beschwerden müssen wir eine ernste Ursache ausschließen. Ich informiere sofort das zuständige Team. Sie werden überwacht, wir legen einen venösen Zugang, kontrollieren die Vitalwerte und beginnen die notwendige Diagnostik. Ich erkläre Ihnen jeden Schritt.

Weekly Practice Plan

Day	Focus
Day 1	Interview motivation: introduce yourself, specialty choice, Germany motivation, stress handling.
Day 2	History taking: chest pain, dyspnea, abdominal pain, fever, dizziness.
Day 3	Orthopedic cases: fall, fracture, knee trauma, back pain, DMS examination.
Day 4	Doctor-to-doctor communication: present five cases in SBAR format.
Day 5	Patient-friendly explanations: tests, risks, consent, discharge advice.
Day 6	Mock interview: perform two complete scripts without reading.
Day 7	Review: record yourself, correct pronunciation, repeat weak phrases.

Minimum daily routine: 10 terms, 5 patient questions, 1 case presentation, 1 personal interview answer.

Study Checklist

Print this page or use it as a weekly digital checklist. Repeat until the German phrasing becomes automatic.

- ☐ Introduce yourself professionally in under 90 seconds.
- ☐ Answer the 10 common interview questions without reading.
- ☐ Explain chest pain, dyspnea, abdominal pain, syncope and stroke symptoms in patient-friendly German.
- ☐ Perform a complete pain history using SOCRATES/OPQRST logic in German.
- ☐ Ask medication, allergy, past medical, surgical, family and social history fluently.
- ☐ Present a patient in structured Arzt-Arzt language in under 2 minutes.
- ☐ Write a short diagnosis and plan using correct German medical terms.
- ☐ Explain informed consent: reason, benefit, risks, alternatives and questions.
- ☐ Pronounce all 100 key terms clearly and consistently.
- ☐ Practise at least 5 full mock interviews aloud.
- ☐ Record three mock presentations and correct word order, articles and endings.
- ☐ Prepare personal examples for stress, teamwork, error management and motivation.
- ☐ Prepare a short explanation of your preferred specialty and training goals.
- ☐ Review red flags: chest pain, acute neurological deficit, severe headache, sepsis signs, cauda equina symptoms and acute abdomen.
- ☐ Practise calm safety phrases: "Das nehmen wir ernst", "Ich informiere sofort den Oberarzt", "Wir überwachen Sie engmaschig".

Final practice rule: Do not memorize only fixed answers. Memorize structures, then adapt them to new cases.